## Введение и методология

**NeuroDraft 3.0** — это экспертная система для автоматизации нейропсихологического обследования и формирования клинических протоколов. Система разработана как связующее звено между классической качественной диагностикой и современными требованиями к количественной стандартизации данных.

1. Методологическая основа

В основу системы заложен системно-динамический подход к высшим психическим функциям (ВСП). Алгоритмы анализа базируются на принципах синдромного анализа, позволяя квалифицировать не только наличие дефицита, но и его первичный радикал (фактор).

2. Философия системы

Основная задача NeuroDraft — трансформация первичных наблюдений специалиста в структурированный документ, соответствующий международным стандартам доказательной медицины. Система обеспечивает:

- **Объективизацию:** Перевод качественных оценок в вариативные метрические системы (Z-scores, T-scores, процентили).
- **Синтез данных:** Объединение результатов нейропсихологических проб с данными нейровизуализации (МРТ/КТ) и скрининговых шкал (MoCA, MMSE, GDS).
- **Клиническую навигацию:** Автоматическое выделение мишеней для реабилитации в соответствии с категориями МКФ (Международной классификации функционирования).

3. Архитектура оценки

Система использует 10-доменную структуру оценки когнитивной сферы. Внутренний расчет ведется по 6-балльной шкале (0 — функциональная сохранность, 5 — полный распад функции). Чтобы обеспечить преемственность данных и исключить методологические барьеры при работе в разных региональных стандартах, система позволяет мгновенно конвертировать исходные баллы в привычные международные метрики. Это позволяет гибко интегрировать NeuroDraft в клинические протоколы различных диагностических школ.

## Технологическая парадигма: Детерминированный синтез vs AI

В отличие от современных стохастических моделей искусственного интеллекта (LLM), склонных к непредсказуемым искажениям данных, в основе NeuroDraft 3.0 лежит **строгая детерминированная архитектура**.

- **Структурная достоверность:** Система оперирует верифицированным массивом клинических данных и лингвистических матриц. Это означает, что каждое слово в итоговом протоколе жестко привязано к конкретному сочетанию введенных факторов.
- **Исключение «галлюцинаций»:** Использование фиксированного, научно обоснованного словаря гарантирует, что система не «придумывает» симптомы, а осуществляет **прецизионный синтез** на основе заданных алгоритмов нейропсихологической диагностики.
- **Валидизация:** Каждая формулировка в массиве прошла экспертную проверку и соответствует классической терминологии нейропсихологической школы, что обеспечивает абсолютную воспроизводимость результатов при идентичных вводных данных.

## Безопасность и конфиденциальность данных

NeuroDraft 3.0 спроектирован с учетом приоритета безопасности персональных данных и врачебной тайны.

- **Локальное хранение:** Система и серверы CogniCore NeuroSystems не хранят персональные данные пациентов. Процесс генерации происходит «на лету»: сформированный протокол передается напрямую в браузер специалиста и загружается на его локальное устройство.
- **Отсутствие централизованной базы:** Система не ведет базу данных обследований, если иное не предусмотрено специфическими требованиями корпоративного заказчика. После закрытия сессии или перезагрузки приложения все введенные временные данные удаляются из оперативной памяти.
- **Ответственность специалиста:** Идентификация пациента (ФИО или ID), а также интерпретация и использование полученных данных являются исключительной ответственностью специалиста. Система предоставляет инструмент синтеза, но финальный клинический вывод остается за лечащим врачом.

4. Статус клинического отчета

Важно понимать, что автоматически сгенерированный протокол является **высокотехнологичным черновиком (advanced draft)**, а не окончательным медицинским заключением.

- **Верификация:** Специалист обязан тщательно вычитать полученный текст и внести правки в случае выявления несоответствий реальной клинической картине.
- **Гибкость:** Система позволяет редактировать итоговый текст непосредственно в интерфейсе или в текстовом редакторе после экспорта.

5. Объективизация: Нейровизуализация и Психометрия

Включение данных МРТ/КТ и результатов скрининговых шкал (MoCA, MMSE, GDS) не является строго обязательным (облигатным) для работы движка, однако крайне желательно для соблюдения высоких стандартов качества мировой нейропсихологии.

- **Синтез:** Эти блоки позволяют системе соотнести функциональный дефицит со структурными изменениями мозга, что значительно повышает достоверность и доказательность отчета.
- **Трудности интерпретации:** При вводе данных визуализации следует учитывать, что клиническая картина не всегда совпадает с очагом поражения на снимке (диашиз, пластичность). Система учитывает эти нюансы, но финальное сопоставление данных остается за экспертом.

## Технический инструментарий и навигация

Для обеспечения бесперебойного рабочего цикла и управления состоянием системы в интерфейс введены инструменты «быстрого действия».

### 1. Функция обнуления данных (♻ RESET / СБРОС)

- **Назначение:** Кнопка мгновенной очистки всех текущих параметров сессии.
- **Механизм:** Нажатие инициирует полный сброс кэша приложения (Session State). Все ползунки возвращаются в положение «0», текстовые поля очищаются, а выбранные пресеты и теги деактивируются.
- **Рекомендация:** Используйте данную функцию перед началом каждого нового обследования, чтобы исключить риск контаминации (смешивания) данных предыдущего пациента с текущим.

### 2. Интерактивное руководство (📖 GUIDE / ГАЙД)

- **Доступность:** Кнопка обеспечивает мгновенный доступ к актуальной версии данного руководства.

- **Контекстная помощь:** В будущих обновлениях данный раздел будет дополнен гиперссылками на конкретные обучающие модули *CogniCore Academy* для глубокого погружения в методологию.

**3. Управление генерацией (🚀 GENERATE REPORT)**

- Ключевой триггер системы. Только после нажатия этой кнопки запускается детерминированный алгоритм синтеза. Если вы изменили параметры (например, передвинули ползунок), необходимо нажать кнопку повторно для обновления аналитического дашборда и текста.

## Пользовательский интерфейс: Ввод данных (Input)

Процесс работы с системой выстроен линейно для минимизации когнитивной нагрузки на специалиста.

**1. Паспортная часть и настройки**

- **Идентификация:** Введите ID или фамилию пациента. Помните о правилах безопасности данных в вашей организации.
- **Scoring System:** Перед началом оценки выберите систему координат (Z-score, T-score и т.д.). Это мгновенно адаптирует подписи ползунков под привычный вам стандарт, хотя в основе расчетов останутся баллы 0–5.

**2. Выбор типа профиля (Core Profile Type)**

Выбор кода является определяющим этапом, задающим базовую архитектуру и «логический движок» всего протокола. Каждый тип профиля определяет специфический лексический словарь и алгоритм синтеза:

- **Коды группы 0 (0, 00, 0+, 0w, 0-, 0*)** Варианты нормы, пограничных состояний или функциональных колебаний.
- **Код 0000:** Профиль «полной недоступности». Используется в случаях грубого нарушения контакта, когда проведение стандартизированных проб невозможно.
- **Коды 1–5 (Органический спектр):** Отражают градиент органического поражения — от легких парциальных дефицитов (1) до тотального когнитивного распада (5).
- **Код 7: (Аффективно-динамический профиль):** Характеризуется первичными нарушениями аффективного контроля и нейродинамики. Отражает специфическую лабильность, где когнитивный дефицит является вторичным по отношению к эмоциональной нестабильности и аффективному фону психической деятельности.
- **Код 8 (РШС — Schizophrenia Spectrum):** Профиль эндогенного круга. Активирует специфическую терминологию (искажение процессов обобщения, мотивационный дефицит) и требует корреляции с нейровекторами.

- **Код 9 (Аффективный профиль):** Депрессивный вариант. Логика синтеза здесь напрямую завязана на показатели шкалы **GDS** и аффективные пресеты.

**3. Оценка когнитивных доменов (10 ползунков)**

- Каждая функция оценивается исходя из результатов проведенных проб.
- Если домен не исследовался, оставьте значение на отметке «0». Система воспримет это как функциональную норму в контексте данного обследования.

**4. Инструментальные данные (MRI/CT & Psychometrics)**

- **MRI LOCALIZATION:** Выберите зоны интереса, подтвержденные снимками. Это активирует соответствующие топические блоки в итоговом тексте.
- **Screening Scales:** Введите баллы шкал. Эти данные влияют на автоматическое определение степени тяжести дефицита и риск депрессивных расстройств в заключении.

**5. Микроструктурный анализ: Надстройки (Пресеты) и Теги**

Помимо базовой оценки доменов, NeuroDraft 3.0 внедряет уровень **феноменологической детализации**, позволяющий радикально повысить «разрешающую способность» итогового протокола.

- **Надстройки (Phenomenology Adjustments):** Это высокоуровневые клинические фильтры, определяющие общую модальность отчета. Выбор пресета (например, *A-sens*, *V-neglect* или *Dep-grief*) перестраивает алгоритм синтеза, заставляя движок учитывать специфическую патогенетическую логику конкретного заболевания.
- **Теги (Clinical Markers):** Инструмент тонкой настройки, позволяющий вносить в отчет уникальные качественные характеристики поведения и когнитивного стиля пациента (от специфических речевых дефектов до нюансов эмоционального реагирования).
- **Алгоритмическая синергия:** Выбранные теги и надстройки не просто добавляют текст, но вступают в сложную аналитическую связь с баллами доменов, создавая уникальную, иерархически выверенную структуру заключения.

*Подробная спецификация и клиническое обоснование каждой надстройки приведены в Приложении №1 (см. раздел «Матрица пресетов и детерминант» в конце данного руководства).*

**5.1. Клинические маркеры (Теги): Психо-поведенческий контекст**

В отличие от доменных оценок, теги системы NeuroDraft 3.0 служат для фиксации **эмоционально-личностного паттерна** и специфики контакта. Они интегрируют в отчет поведенческие нюансы, которые критичны для дифференциальной диагностики и прогноза реабилитации.

**Примеры категорий тегов:**

- **Регистр РШС (8-типы контакта):** Позволяет специфицировать форму социального и коммуникативного дефекта.
    - *8paranoid* — отражает подозрительность и элементы сверхценной настроенности;
    - *8mannerism* — фиксирует вычурность и неадекватность поведенческих актов;
    - *8withdrawn* — маркирует аутизацию и глубокий уход во внутренний мир.
- **Личностные детерминанты:** Описывают преморбидный фон или развившиеся девиации.
    - *antisocial-p* — вносит в протокол признаки асоциальных установок и нарушения волевого контроля;
- **Анамнестические следы (History markers):** Учитывают влияние прошлого опыта на текущий статус.
    - *tox-hist* — маркирует «токсический след» (хронические интоксикации), меняющий нейродинамический фон;
    - *panic-history* — указывает на наличие панических атак в анамнезе, объясняя специфическую тревожность при тестировании.
- **Аффективные реакции на дефект:**
    - *psd (post-stroke depression)* — фиксирует вторичную депрессивную реакцию на осознание болезни, что важно для разграничения первичного дефицита и реактивных состояний.

**Клиническое значение:** Использование тегов позволяет перевести сухой количественный отчет в плоскость **индивидуально-психологического портрета**, обеспечивая преемственность данных между психологом, психиатром и реабилитологом.

## Аналитический Дашборд: Интерпретация данных (Output)

После нажатия кнопки «Generate Report» система формирует многоуровневый аналитический дашборд, который служит визуальным и математическим подтверждением клинического вывода.

### 1. Топическая диагностика: Heatmap (Блоки мозга)

- Визуальная модель трех функциональных блоков мозга (по классификации А. Р. Лурии).
- **Градиентная подсветка:** Система автоматически рассчитывает «вес» поражения для каждой структуры. Самый яркий (насыщенный) блок указывает на первичный очаг дефицита («эпицентр»), в то время как более бледные оттенки маркируют сопутствующую (вторичную) дисфункцию.

### 2. Системные синдромы (Сети)

- Индикаторы сетевых паттернов указывают на специфический характер поражения (сосудистый, дегенеративный, подкорковый и др.). Активация конкретной «сети» помогает специалисту дифференцировать системный сбой от локального дефекта.

### 3. Clinical Metrics (Таблица математической верификации)

- Левая таблица дашборда представляет количественный срез по всем 10 доменам. Данные отображаются в выбранной вами метрической системе (Z-scores и др.) с цветовой индикацией «светофора» (зеленый/желтый/красный), что позволяет мгновенно оценить масштаб дефицита.

### 4. Rehab Targets (Мишени МКФ)

- Правая таблица автоматически конвертирует выявленные функциональные нарушения в коды Международной классификации функционирования (МКФ). Это готовый перечень **реабилитационных мишеней**, на основе которых выстраивается индивидуальный план восстановительного обучения.

## Финальный этап: Экспорт и работа с протоколом

Завершающим звеном рабочего процесса является формирование и выгрузка официального документа.

**1. Интеллектуальное форматирование (Mayo/Boston Standard)**
При нажатии кнопки 📥 **WORD** система генерирует документ, соответствующий канонам международной академической верстки:

- **Типографика:** Использование шрифтов группы *Sans Serif* (Helvetica/Arial) обеспечивает максимальную читаемость и стерильность документа.
- **Визуальные акценты (Semantic Highlighting):** Алгоритм экспорта автоматически распознает и выделяет жирным шрифтом ключевые клинические маркеры, степени тяжести и коды МКФ. Это создает «навигационную карту» текста для быстрого ознакомления смежных специалистов.

**2. Интеграция графики**
Визуальный профиль (радарная диаграмма) конвертируется в высококонтрастное изображение на светлом фоне, адаптированное для печати на лазерных принтерах без потери детализации.

**3. Постобработка**
Система поддерживает функцию быстрого копирования текста (📋 **COPY**) для мгновенного переноса данных в электронные медицинские карты (EHR) или иные внутренние системы учета.

## Приложение №1: Матрица клинических модификаторов

Для достижения экспертной точности отчета NeuroDraft 3.0 использует двухуровневую систему модификации текста: **Пресеты** и **Теги**.

1. ПРЕСЕТЫ (Надстройки и Сетевые синдромы)

Пресеты — это «функциональные фильтры». Они меняют не просто слова, а **патогенетическую логику** синтеза всего протокола.

- **Регуляторные и нейродинамические (ndyn, r-reg, l-reg):** Фокусируют отчет на дефиците контроля, программирования и инактивности (передние отделы мозга).
- **Афазические и гностические (a-sens, a-eff, a-dyn, v-gnosis и др.):** Активируют детализированное описание инструментальных нарушений (речь, зрение, праксис). Это база для «органических» типов профиля (1–5).
- **Сетевые синдромы (vci-svd, msa, ccas, thalam, retic, striar, callosal-ds):** Самый мощный инструмент. Выбор сетевого пресета заставляет систему описывать дефицит как результат **системного сбоя** (например, таламического или мозжечкового), а не локального очага.
- **Аффективный регистр (dep-grief, dep-somatic, dep-cog, dep-anxious, dep-adjustment):** 5 версий депрессивного фильтра. Они «окрашивают» когнитивные жалобы в цвета аффективного расстройства, что критично для **Типа 9**.

2. ТЕГИ (Клинические маркеры)

Теги — это «точечные инъекции» смысла. Они вкрапляются в текст, добавляя важные нюансы поведения и анамнеза, не меняя общей структуры синдрома.

- **Регистр РШС (8-типы):** *8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn*. Специфицируют контакт и мышление при **Типе 8**.
- **Поведенческие детерминанты:**
  - *malingering-p:* Вводит в отчет указание на признаки аггравации или установочного поведения (критично для страховой медицины).
  - *antisocial-p:* Описывает нарушение социальных норм и волевого контроля.
- **Медицинский контекст:**
  - *tox-hist:* Учитывает влияние интоксикаций.
  - *medical-comorbidity:* Добавляет соматический фон, объясняющий общую слабость или когнитивную лабильность.
  - *psd:* Уточняет реактивную природу депрессии (после инсульта).
- **Специфические феномены:** *anomia* (трудности называния), *panic-history* (тревожный след).

ТАБЛИЦА A: ПРЕСЕТЫ (Adjustments & Networks)

*Влияют на логику движка, структуру предложений и топический синтез.*

| Код пресета | Группа | Клиническое содержание и влияние на отчет |
|---|---|---|
| **ndyn, a-dyn** | **Нейродинамика** | Отражают дефицит активации. Сдвигают акцент на темп, истощаемость и инертность психических процессов. |
| **r-reg, l-reg** | **Регуляция** | Программирование и контроль. Активируют описание «переднего» дефекта (префронтальные отделы). |
| **v-gnosis, v-neglect** | **Зрительный гнозис** | Активируют блоки по зрительному восприятию и феномены игнорирования пространства. |
| **apr-dyn, kin, con** | **Праксис** | Детализируют нарушения произвольных движений (динамический, кинестетический, конструктивный праксис). |
| **a-sens, a-eff, a-aff a-amn, a-sem** | **Речь** | Специфицируют тип речевого дефицита (сенсорный, эфферентный, афферентный компоненты). Уточняют характер амнестических и семантических трудностей. |
| **vci-svd** | **NETWORK: Сосуд** | **Ключевой сетевой пресет.** Генерирует отчет через призму цереброваскулярной болезни (ДЭП). Подсвечивается в дашборде. |
| **msa, ccas** | **NETWORK: Систем** | **Сетевые пресеты.** Описывают мультисистемную атрофию или мозжечковый когнитивно-аффективный синдром. |
| **thalam, retic, striar** | **NETWORK: Подкорка** | **Топические сети.** Переводят отчет в плоскость подкорковых поражений (таламический, ретикулярный, стриатарный синдромы). |
| **callosal-ds** | **NETWORK: Связи** | **Сетевой пресет.** Описывает синдром межполушарного дисконнекта. |
| **dep- (grief, somatic, cog, anxious, adjustment)** | **Affective Fillers** | **Аффективные надстройки.** 5 вариантов депрессии. Перестраивают отчет под клинику сниженного настроения и психосоматики. |

ТАБЛИЦА Б: ТЕГИ (Clinical Markers)

*Добавляют точечные качественные характеристики, не меняя глобальную структуру синдрома.*

| Код тега | Категория | Значение для интерпретации |
|---|---|---|
| **8paranoid, 8mannerism, 8withdrawn** | **Спектр РШС** | Специфицируют тип контакта и поведенческие странности при эндогенном процессе. |
| **tox-hist** | **Анамнез** | Указывает на экзогенно-токсический фон (алкоголь, ПАВ, химия). |
| **malingering-p** | **Установка** | Маркирует подозрение на аггравацию, симуляцию или установочное поведение. |
| **antisocial-p** | **Личность** | Описывает дефицит эмпатии, агрессивность и нарушение социальных границ. |
| **medical-comorbidity** | **Соматика** | Учитывает влияние тяжелых соматических заболеваний на когнитивный статус. |
| **a-sensory** | **Симптом** | Отражает дефицит сенсорного восприятия или специфическую слуховую/сенсорную агнозию. |
| **anomia** | **Симптом** | Внедряет в речевой блок описание трудностей называния предметов. |
| **panic-history** | **Тревога** | Указывает на наличие панических атак, объясняя тревожный фон обследования. |
| **psd** | **Реакция** | Постинсультная депрессия. Разграничивает органический дефект и эмоциональную реакцию на него. |